3.1.7.2. 연명의료결정 환자 진료

제 정 일	2006.07.	최 종 개 정 일	2025.07.04.	최 종 검 토 일	2025.07.04.
담 당 부 서	완화의료센터				
유 관 부 서					

관 련 기 준	4주기 의료기관인증기준: 3.1.7 환자진료, 6.1 환자권리존중 및 보호 JCI Standard 7th Edition: PCC.2.1, 2.2, COP.3, 7

제1조 (목적)

1. 환자의 생명을 연장하기 위해 연명의료를 적용하거나 더 이상 생명을 연장하는 것이 무의미하다고 판단되어 연명의료를 유보·중단하게 되는 경우, 환자의 요구를 파악하고 이에 부합하는 의료를 제공하며, 의료진에게 의사결정 지침을 제공하기 위함이다.

제2조 (정의)

1. 연명의료(Life-Sustaining Treatment)
   1) 임종과정에 있는 환자에게 하는 심폐소생술, 혈액 투석, 항암제 투여, 인공호흡기 착용, 체외생명유지술, 수혈, 혈압상승제 투여, 그 밖에 담당의사가 환자의 최선의 이익을 보장하기 위해 중단할 필요가 있다고 판단하는 의학적 시술로서 치료효과 없이 임종과정의 기간만을 연장하는 의료
2. 말기환자(Terminally Illness)
   1) 의사와 해당분야의 전문의 1명으로부터 수개월 이내에 사망할 것으로 예상되는 진단을 받은 환자
   2) 적극적인 치료에도 불구하고 근원적인 회복의 가능성이 없고 점차 증상이 악화되는 환자
3. 임종과정
   1) 회생의 가능성이 없고, 치료에도 불구하고 회복되지 아니하며, 급속도로 증상이 악화되어 사망에 임박한 상태
4. 임종과정에 있는 환자
   1) 의사와 해당 분야의 전문의 1명으로부터 임종과정에 있다는 의학적 판단을 받고 임종과정에 있는 환자 판단서 서식이 작성된 자
5. 연명의료중단등결정
   1) 임종과정에 있는 환자에 대한 연명의료를 시행하지 아니하거나 중단하기로 하는 결정
6. 연명의료계획서
   1) 말기·임종기 환자 등의 의사에 따라 담당의사가 환자에 대한 연명의료중단등결정 및 호스피스에 관한 사항을 계획하여 문서로 작성한 것
7. 사전연명의료의향서
   1) 19세 이상인 사람이 자신의 연명의료중단등결정 및 호스피스에 관한 의사를 직접 문서로 작성한 것

제3조 (절차)

1. 연명의료환자 진료의 기본원칙
   1) 호스피스와 연명의료 및 연명의료중단등결정에 관한 모든 행위는 환자의 인간으로서의 존엄과 가치를 침해하여서는 아니된다.
   2) 모든 환자는 최선의 치료를 받으며, 자신이 앓고 있는 질병의 상태와 예후 및 향후 본인에게 시행될 의료행위에 대하여 분명히 알고 스스로 결정할 권리가 있다.
   3) 의료진은 환자에게 최선의 치료를 제공하고, 호스피스와 연명의료 및 연명의료중단등결정에 관하여 정확하고 자세하게 설명하며, 그에 따른 환자의 결정을 존중하여야 한다.

2. 연명의료계획서의 작성 · 등록 등
   1) 의사는 말기·임종기 환자 등에게 연명의료중단등결정, 연명의료계획서 및 호스피스에 관한 정보를 제공할 수 있다.
      (1) 정보제공 대상: 말기·임종기 환자
      (2) 정보제공 방법: 설명 및 상담, 인쇄물
   2) 말기 · 임종기 환자 등은 의사에게 연명의료계획서의 작성을 요청할 수 있다.
   3) 연명의료계획서 작성 요청을 받은 의사는 해당 환자에게 연명의료계획서에 대해 설명하고, 환자로부터 내용을 이해하였음을 확인받아야 한다. 이 경우 해당 환자가 미성년자인 때에는 환자 및 그 법정대리인에게 설명하고 확인을 받아야 한다.
   4) 환자는 연명의료계획서의 변경 또는 철회를 언제든지 요청할 수 있다. 이 경우 의사는 이를 반영한다.

3. 연명의료중단등결정 이행
   1) 연명의료중단등결정 이행의 대상
      (1) 의사는 임종과정에 있는 환자가 다음 어느 하나에 해당하는 경우에만 연명의료중단등결정을 이행할 수 있다.
         ① 연명의료계획서, 사전연명의료의향서 또는 환자가족의 진술을 통하여 환자의 의사로 보는 의사가 연명의료중단등결정을 원하는 것이고, 임종과정에 있는 환자의 의사에도 반하지 아니하는 경우
         ② 절차 3. 4) 참조(환자의 의사를 확인할 수 없는 경우의 연명의료중단등결정)
   2) 환자의 임종과정에 있는지 여부에 대한 판단
      (1) 의사는 환자에 대한 연명의료중단등결정을 이행하기 전에 해당 환자가 임종과정에 있는지 여부를 해당 분야의 전문의 1명과 함께 판단하고 그 결과를 기록한다.
   3) 환자의 의사 확인
      (1) 연명의료중단등결정을 원하는 환자의 의사는 다음 방법으로 확인한다.
         ① 의료기관에서 작성된 연명의료계획서가 있는 경우 이를 환자의 의사로 본다.
         ② 등록된 사전연명의료의향서가 있으면 담당의사가 국립연명의료관리기관에서 조회한 사전연명의료의향서의 내용을 환자에게 확인하는 경우 이를 환자의 의사로 본다. 담당의사 및 해당 분야의 전문의 1명이 환자가 사전연명의료의향서의 내용을 확인하기에 충분한 의사능력이 없다고 의학적으로 판단하고 적법하게

작성되었다는 사실을 확인한 경우에도 같다.

③ 19세 이상의 환자가 의사를 표현할 수 없는 의학적 상태인 경우 환자가 충분한 기간 동안 일관되게 표시한 연명의료중단등결정에 관한 의사에 대하여 환자가족 2명 이상의 일치하는 진술이 있으면 담당의사와 해당 분야의 전문의 1명의 확인을 거쳐 이를 환자의 의사로 본다. 다만, 그 진술과 배치되는 내용의 다른 환자가족의 진술 또는 객관적인 증거가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

④ 환자 가족의 범위는 19세 이상인 자로 배우자, 직계비속, 직계존속을 말하며 모두없는 경우 형제, 자매가 해당된다. 환자 가족이 1명만 있는 경우에는 해당하는 1명의 진술로 가능하다.

4) 환자의 의사를 확인할 수 없는 경우의 연명의료중단등결정

(1) 환자의 의사를 확인할 수 없고 환자가 의사표현을 할 수 없는 의학적 상태인 경우 다음 중 하나에 해당할 때에는 해당 환자를 위한 연명의료중단등결정이 있는 것으로 본다. 다만, 담당의사 또는 해당 분야 전문의 1명이 환자가 연명의료중단등결정을 원하지 아니하였다는 사실을 확인한 경우는 제외한다.

① 미성년자인 환자의 법정대리인(친권자에 한정한다)이 연명의료중단등결정의 의사표시를 하고 담당의사와 해당 분야 전문의 1명이 확인한 경우

② 환자가족 전원의 합의로 연명의료중단등결정의 의사표시를 하고 담당의사와 해당 분야 전문의 1명이 확인한 경우

③ 환자 가족의 범위는 배우자와 1촌 이내의 직계존속·비속에 해당하며, 이에 해당하는 사람이 없는 경우 2촌 이내의 직계존속·비속, 이에 해당하는 사람이 없는 경우 형제자매를 말한다.

5) 연명의료중단등결정 과정에서 환자의 가족범위

(1) 연명의료중단등결정에 대한 환자의사 확인서(환자가족 진술)[11호]

① 19세 이상인 사람으로,

a. 배우자

b. 직계 비속

c. 직계 존속

d. 형제자매(위 조건에 해당하는 사람 없는 경우)

(2) 연명의료중단등결정에 대한 친권자 및 환자 가족의사 확인서[12호]

① 19세 이상인 사람으로,

a. 배우자 및 1촌 이내 직계 존속·비속

b. 2촌 이내의 직계 존속·비속(a에 해당하는 사람 없는 경우)

c. 형제자매 (위 조건에 해당하는 사람 모두 없는 경우)

(3) 환자가족이 1명만 있는 경우에는 해당하는 1명의 진술로 가능

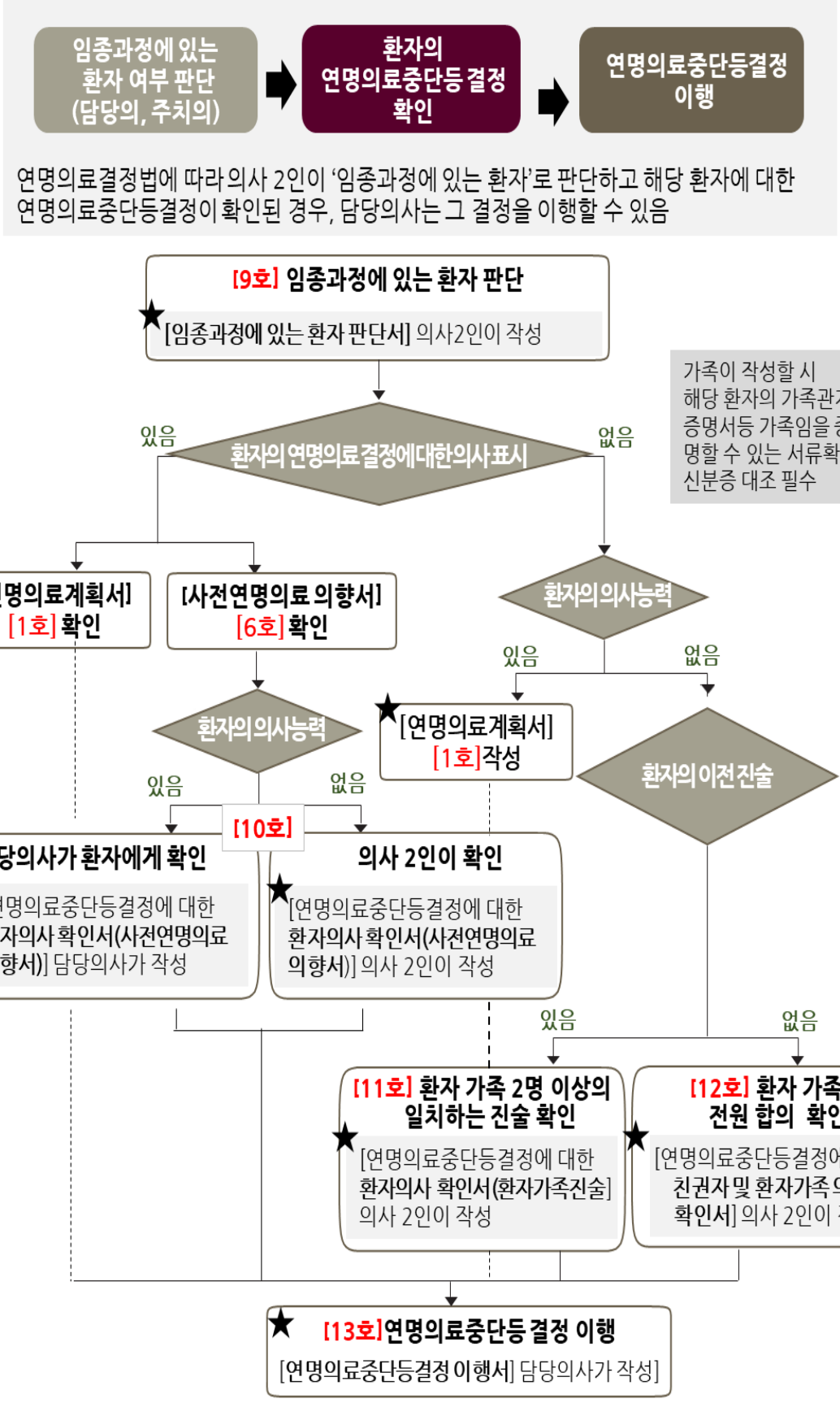
(4) 제외 가족

① 경찰관서에 행방불명 사실이 신고된 날부터 1년 이상 경과한 사람

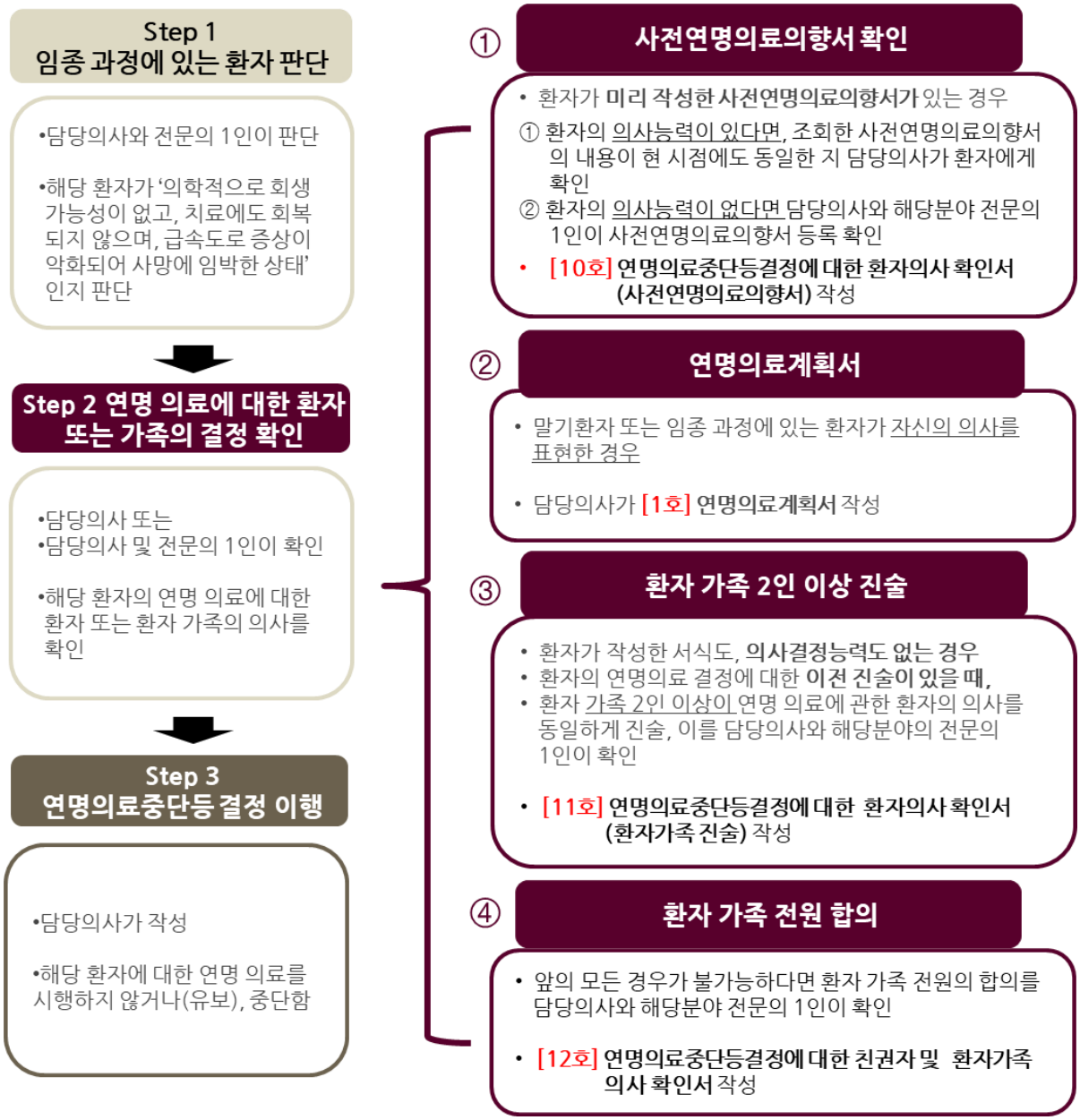
② 실종선고 받은 사람

③ 의식불명 또는 이에 준하는 사유로 자신의 의사를 표명할 수 없는 의학적 상태에 있는 사람으로서 해당 의학적 상태에 대하여 전문의 1명 이상의 진단·확인을 받은 사람

6) 연명의료중단등결정의 이행에서 중단할 수 있는 연명의료
   (1) 임종과정에 있는 환자에게 하는 심폐소생술, 혈액투석, 항암제 투여, 인공호흡기 착용, 체외생명유지술, 수혈, 혈압상승제 투여
   (2) 그 밖에 담당의사가 환자의 최선의 이익을 보장하기 위해 중단할 필요가 있다고 판단하는 의학적 시술로서 치료효과 없이 임종과정의 기간만을 연장하는 의료
   (3) 단, 통증 완화를 위한 의료행위와 영양분 공급, 산소의 단순 공급은 시행하지 않거나 중단할 수 없다.
7) 환자와 대리인에게 심리, 사회, 영적 돌봄을 제공하며, 필요 시 완화의료센터에 협의진료를 의뢰한다.
8) 의도적으로 환자의 생명을 단축하거나 자살을 돕는 행위는 허용하지 않는다.
9) 담당 의료진은 연명의료에 관한 일체의 결정 과정을 기록하고 다음 규정에 따라 보존한다.
   (1) 연명의료중단등결정 이행 후 10년 보존
   (2) 해당 기록 허위 작성 시 3년 이하 징역 또는 3천만원 이하의 벌금
   (3) 해당 기록 보존 의무 위반 시 300만원 이하 벌금
10) 이행의 통보
   (1) 연명의료중단등결정의 이행 결과를 지체없이 관리기관의 장에게 통보하여야 한다.
   (2) 이행 결과를 통보하지 않을 시 500만원 이하의 과태료 부과
11) 의료진은 환자의 상태 변화가 있는지 모니터링하고 상태 변화 시 연명의료와 관련하여 환자(대리인)와 협의한다.
12) 연명의료 관련 이견이 있을 경우 결정에 도움을 받을 수 있도록 연명의료윤리 위원회에 상정한다.
13) 연명의료윤리위원회는 연명의료결정 관련된 교육을 실시한다.
14) 치료와 검사를 위해 필요 시 특수 장비를 사용할 수 있다.
15) 연명의료 환자 진료 프로세스: 도식 참고



<연명의료 환자 진료 프로세스>



<연명의료 환자 진료 프로세스>

제4조 (부록)

제5조 (참고)

내규의 제 · 개정 이력

제1조 (내규의 제정 및 시행)

1. 이 내규는 2006년 7월부터 시행한다.

제2조 (내규의 전면개정 및 시행)

1. 이 내규는 2025년 3월 25일부터 시행한다.

제3조 (내규의 개정)

1. 이 내규는 2025년 7월 4일부터 시행한다.

승 인 : 세브란스병원장 이 강 영 (인)